SDD 141 Sujet n°1

Spécialité : Ophtalmologie

Date : 17/09/2023
Auteur : BLANC Adrien (DES ophtalmologie Grenoble)
Relecteur(s) : VILLARD Sébastien (DES MIIC Paris), DEGACHI Alexandre (ex DES MIIC Paris), Mansour ARSALANE (DES Ophtalmologie Paris) , Alexandre BOURDIN (DES Ophtalmologie Paris)

Domaine d'apprentissage principal	Entretien/interrogatoire
Domaine d'apprentissage secondaire	Stratégie diagnostique
Item(s) en lien avec la station	83 - Infections et inflammation oculaire 192 - Pathologies auto-immunes
Situation(s) de départ en lien avec la station	SDD 141 - Sensation de brûlure oculaire
Matériel nécessaire à la station	Chaises. Table. Une photographie
Contexte de la station	Une patiente de 35 ans présente un syndrome sec oculaire. Le médecin amorce la démarche diagnostique et la prise en charge.

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes interne en médecine générale en centre pluriprofessionnel de santé.

Vous recevez la patiente Madame Aurélie VILLIÈRE, âgée de 35 ans, au cabinet et qui présente une sensation de brûlure oculaire dans un contexte d'asthénie.
Elle a été diagnostiquée il y a 10 ans d'un lupus aigu cutané, sans atteinte viscérale. Elle est bien suivie depuis.

La patiente est seule en consultation.

Consignes :
Vous devez en 8 minutes :

- Mener l'interrogatoire et proposer les tests diagnostiques ophtalmologiques adéquats
- Évoquer votre principale hypothèse diagnostique
- Proposer la prise en charge initiale

Vous ne devez pas :

- Rédiger d'ordonnance
- Réaliser l'examen clinique
- Réaliser techniquement d'examen complémentaire

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques			
Interrogatoire			
1.	Recherche une antériorité clinique similaire	1 pt	☐
2.	Recherche la fréquence des épisodes	1 pt	☐
3.	Recherche les facteurs irritants ou aggravants parmi : vapeurs chimiques, tabac, poussière, soleil, air sec, air chaud pulsé	1 pt si au moins 2 éléments	☐
4.	Caractérise les conséquences fonctionnelles : gêne au travail ET/OU conduite ET/OU autres activités de la vie quotidienne	1 pt : si au moins un élément	☐
5.	Recherche les signes oculaires associés : sensation de grains de sable OU brûlure oculaire ET/OU rougeur conjonctivale ET/OU baisse de l'acuité visuelle	1 pt si au moins 2 éléments	☐
6.	Recherche un port de lentilles de contact	1 pt	☐
Hypothèse diagnostique et exploration			
7.	Propose un test de Schirmer	1 pt	☐
8.	Évoque le diagnostic de syndrome sec oculaire objectif	1 pt	
9.	Évoque un probable Gougerot-Sjogren	1 pt	☐
Prise en charge			
10.	Initie un traitement par substituts lacrymaux	1 pt	☐
11.	Conseille l'éviction des facteurs irritants ou aggravants : vapeurs chimiques, tabac, poussière, soleil, air sec ou air chaud pulsé	1 pt si au moins 2 éléments	☐ ☐

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

12.	Oriente le patient vers un ophtalmologiste	1 pt	☐

Communications et attitudes

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

2. APTITUDE À QUESTIONNER

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Pose des questions fermées ou trop directives ou qui ne répondent pas aux objectifs Utilise le jargon médical	Pose des questions qui s'éloignent des objectifs Utilise quelques fois un jargon médical sans explication	Utilise différents types de questions couvrant les éléments essentiels Utilise quelques fois un jargon médical mais toujours avec explications	Pose des questions précises couvrant la plupart des éléments avec quelques omissions mineures Utilise le langage approprié	Pose les questions avec assurance et savoir-faire

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

12. APTITUDE À PROPOSER UNE PRISE EN CHARGE (situations aiguës / chroniques)

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Est incapable de proposer une prise charge adaptée à la situation clinique	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels, n'arrive pas à justifier la démarche	Propose une prise en charge en couvrant les éléments essentiels et justifie la démarche.	Propose une prise pertinente. Ne s'attarde pas au traitement/prise en charge inutile et justifie la démarche.	Etablit l'ordre de priorité des différents aspects de la prise en charge du patient (hiérarchise).

TOTAL	16 points

<u>Éléments de rétroaction :</u> (facultatif)

Cette station peut paraître dure à négocier, cependant on se tient strictement aux attendus nationaux des compétences pour la SDD 141 - Sensation de brûlure oculaire.

L'énoncé est clair, il s'agit d'un tableau de pathologie **auto-immune**, chez une femme jeune, à implication ophtalmologique. Ici on pense d'abord à un syndrome sec secondaire à un **Syndrome de Gougerot-Sjögren**.
L'interrogatoire de la patiente oriente sur la plainte ophtalmologique uniquement et il faut rester clinique. Bien penser à **objectiver** le trouble: L'instillation de fluorescéine (par l'ophtalmologiste) permet de d'évaluer le break-up time et de rechercher une kérato-conjonctivite sèche; un test de Schirmer peut également être proposé.
Pour la prise en charge, il faudra d'une part traquer les **facteurs favorisants** (tabac, climatisation…) afin de donner des conseils pratiques ; et d'autre part mettre en place un **traitement symptomatique** (larmes artificielles).
La prise en charge complète échappant aux prérequis du 2eme cycle, il faut avoir le réflexe **d'orienter** le patient chez l'ophtalmologiste.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Vous êtes interne de médecine générale.

Nous sommes au mois de Juin.

Vous recevez la patiente Madame Aurélie VILLIÈRE, âgée de 35 ans au cabinet et qui présente une sensation de brûlure oculaire. Elle a été diagnostiquée il y a 10 ans d'un lupus. Elle est bien suivie.

La patiente est seule en consultation.

<u>Consignes</u> :
Vous devez réaliser en 7
8 minutes :

- Mener l'interrogatoire et proposer les tests diagnostiques adéquats
- Évoquer votre principale hypothèse diagnostique
- Mettre en place la prise en charge

Vous ne devez pas :

- Rédiger d'ordonnance
- Réaliser l'examen clinique
- Réaliser techniquement d'examen complémentaire

Plan de la station ECOS :

Le patient simulé se trouve en face du candidat, chacun assis sur une chaise, séparée d'une table.

Sur la table se trouve 2 photographies :

- d'un oeil en lumière blanche
- une du résultat de l'examen à la fluorescéine

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Mon oeil me brûle depuis plusieurs jours"

Identité du patient :

Femme
VILLIERE Aurélie
35 ans

Mode de vie :

Avocate.
Tabagique : depuis 18 ans / 1 paquet par jour.

Facteur irritants/aggravants du syndrome sec présent chez cette patiente :
- tabac
- climatisation du cabinet d'avocat
- Exposition au soleil fréquente

Pas d'allergies. Pas d'intolérances.

Comportement global :

La patiente est coopérante. Elle est dérangée par ce problème qui l'empêche de travailler correctement. Elle aimerait une solution pratique et rapide.

Antécédents personnels :

Lupus érythémateux systémique avec atteinte cutanée diagnostiqué il y a 10 ans. Maladie contrôlée sous Hydroxychloroquine seule.

La patiente ne porte pas de lentilles de contact.

Antécédents familiaux :

Aucun

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Médicaments :

HYDROXYCHLOROQUINE

Symptômes positifs :

- Si l'étudiant demande de préciser la sensation oculaire -> "ça brûle et ça gratte comme si j'avais du **sable** dans l'oeil" / se gratter les yeux
- Si l'étudiant demande si cette sensation est douloureuse -> "Pas beaucoup c'est surtout très **gênant**, j'ai du mal à avancer dans mes dossiers"
- Si l'étudiant demande de coter la douleur -> "2/10" / "Légère"
- Si l'étudiant demande si la vision est affectée -> "Ca me force à fermer l'oeil surtout en soirée" et "parfois j'y vois **trouble**"
- Si l'étudiant demande si cette sensation d'oeil sec s'est déjà produite -> "Il y a 6 mois"
- Si l'étudiant demande quand a débuté l'épisode actuel -> "Il y a 2 semaines"
- Si l'étudiant demande la fréquence de la gêne oculaire -> "Je suis gênée tous les jours, surtout le soir"
- Si l'étudiant demande si il y a d'autres lésion/gênes -> "Non, tout va bien autrement"
- Si l'étudiant demande si la patiente porte des lentilles de contact-> "non"

Constantes :

Inutile.

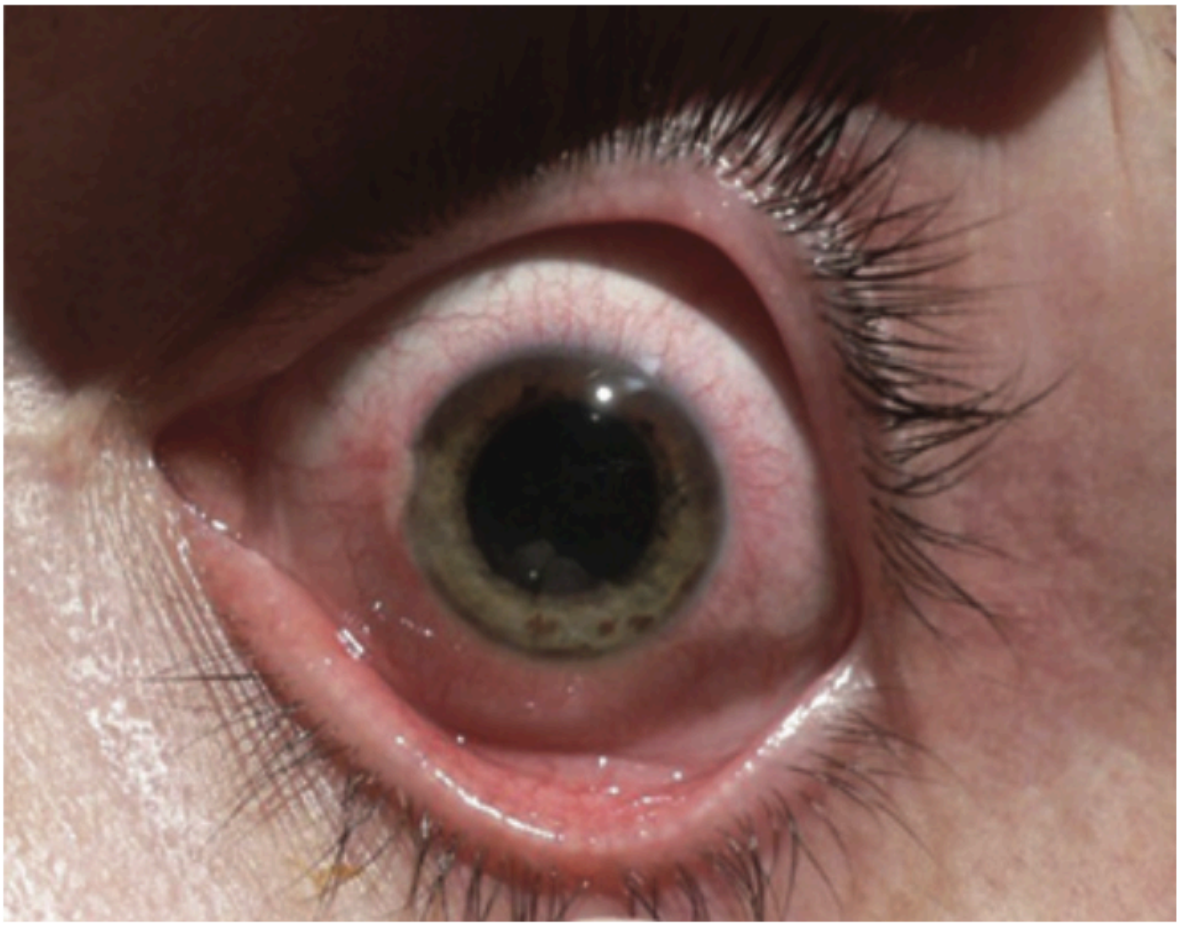
Donnée complémentaire :

Photographies d'un oeil -> disponibles dès le début. Compte rendu du résultat du test de schirmer -> remis uniquement si l'étudiant propose le test.

Questions de relance :

Si à 6' le candidat n'a pas proposé de prise en charge -> "Docteur,j'ai besoin de pouvoir lire de nouveau, qu'est ce que je peux avoir comme traitement ?"

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)



Compte-Rendu : Test de Schirmer

Résultats :

- *Œil droit : 6 mm à 5 minutes.*
- *Œil gauche : 8 mm à 5 minutes.*

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Lucie-Lou VIAL (VP ECOS, DES d'Anesthésie-réanimation à Toulouse), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)